Guia de Psicofármacos

Nov 10, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

A regra-mãe

Quase todo psicofármaco se lembra pelo neurotransmissor em que mexe. Saiba o que cada neurotransmissor faz e você deduz quando usar o remédio e qual efeito colateral esperar, sem decorar listas.

Neurotransmissor	O que faz	Remédio que aumenta	Remédio que bloqueia ou freia
Serotonina	Regula emoção negativa, ansiedade e obsessão	ISRS e IRSN: depressão com choro e ansiedade, TAG, pânico, TOC, TEPT, bulimia	Antipsicóticos atípicos bloqueiam o 5-HT2A
Noradrenalina	Energia, interesse, atenção, alerta	IRSN e bupropiona: depressão sem interesse e com cansaço	Doxazosina e propranolol: hiperalerta do trauma
Dopamina	Motivação e recompensa; em excesso gera psicose	Bupropiona e lisdexanfetamina: falta de vontade, compulsão alimentar	Antipsicóticos: psicose, mania, TOC refratário
GABA	O freio do cérebro	Benzodiazepínicos: ansiedade aguda, convulsão, abstinência alcoólica	
Glutamato	O acelerador do cérebro		Pregabalina, lamotrigina, memantina, N-acetilcisteína, escetamina

Três ideias que valem para todos:

1. **Antidepressivo demora 6 a 8 semanas** e pode piorar a ansiedade no começo, então se inicia em dose baixa.
2. **Benzodiazepínico age em minutos**, mas vicia: é ponte ou resgate, nunca o tratamento principal.

3. **O efeito colateral é o próprio mecanismo em outro lugar do corpo.** O antipsicótico que bloqueia a dopamina da psicose também bloqueia a do movimento e dá rigidez.

Antidepressivos

Como escolher: olhe o sintoma que predomina.

- **"Sente demais"** (choro, irritabilidade, ansiedade): **ISRS**, que aumentam a serotonina.
- **"Está sem gasolina"** (sem energia nem vontade): bupropiona, que aumenta dopamina e noradrenalina.
- **"Nada interessa"** (sem interesse, concentração ruim): IRSN, que somam a noradrenalina.
- **"Não dorme e não come":** mirtazapina ou trazodona, que dão sono.

ISRS (inibidores seletivos da recaptação de serotonina): primeira linha em quase tudo

Usados em depressão, TAG, pânico, ansiedade social, TOC (em dose alta), TEPT e bulimia. Efeitos: disfunção sexual, embotamento, hiponatremia no idoso e sangramento.

Remédio	Dose	Quando escolher	Gancho
Fluoxetina	20 a 80 mg	Criança, gestante, bulimia (único aprovado), SUS	"FLUi para todo lado": a mais versátil e de meia-vida longa
Sertralina	50 a 200 mg	Gestação, amamentação, cardíaco	"SERTA para o coração e o bebê"
Escitalopram	10 a 20 mg	Ansiedade e depressão em geral	Fração ativa do citalopram; no idoso acima de 85 anos, máximo de 15 mg
Citalopram	20 a 40 mg	Menos potente	Máximo de 30 mg acima de 85 anos (QTc)
Paroxetina	20 a 60 mg	Ansiedade	"PARa a vida sexual e aumenta o peso": a mais serotoninérgica e com mais efeitos
Fluvoxamina	100 a 300 mg	TOC	"FLUVOX = TOC"

IRSN (inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina)

Remédio	Dose	Quando escolher	Gancho
Venlafaxina	75 a 225 mg	Depressão grave, TAG, pânico	Só vira dupla acima de cerca de 150 mg; sobe a pressão; retirada forte
Desvenlafaxina	50 a 200 mg	Polimedicado; fogachos da menopausa	"DES-complicada": quase sem interação
Duloxetina	60 a 120 mg	Depressão com dor crônica ou neuropática	"DULOr": trata dor mesmo sem depressão; cuidado com fígado e álcool

Outros antidepressivos

Remédio	Dose	Quando escolher	Gancho
Bupropiona	150 a 300 mg	Sem energia, tabagista, queixa sexual com ISRS	"BUP = BUsca de energia e Para de fumar"; proibida na bulimia
Mirtazapina	30 a 45 mg	Depressão com insônia e pouco apetite	"MIRTA engorda e faz dormir"
Trazodona	25 a 150 mg para sono; 150 a 375 mg para depressão	Depressão com insônia e ansiedade	"TRAZ o sono"
Vortioxetina	10 a 20 mg	Queixa de memória e concentração	"VORTEX da cognição"; náusea
Vilazodona	20 a 40 mg	Depressão ansiosa, sem querer perder a libido	Tomar com comida (náusea e diarreia)
Agomelatina	25 a 50 mg	Ritmo do sono desregulado	"AGO-MELATONINA": relógio biológico; checar fígado

Tricíclicos

Amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina. Funcionam (depressão a partir de 75 mg), mas mexem em muitos receptores. **Uso hoje: dor crônica, enxaqueca, enurese e intestino irritável em dose baixa, e clomipramina no TOC.** Gancho dos riscos: "coração, convulsão e confusão no idoso".

Os que poupam a vida sexual: bupropiona, trazodona, vilazodona, vortioxetina e desvenlafaxina.

Estabilizadores do humor

A ideia: no bipolar o objetivo é segurar o pêndulo do humor e impedir o próximo episódio, por isso o tratamento é contínuo. Cada estabilizador "segura" melhor um dos lados: lembre que **o valproato segura em cima (mania) e a lamotrigina segura embaixo (depressão)**, enquanto lítio e quetiapina seguram os dois.

Remédio	Quando usar	Como prescrever	Cuidados	Gancho
Lítio	Todas as fases do TAB; antissuicídio em qualquer transtorno; potencializa antidepressivo	Dose pela litemia: cerca de 1,0 mEq/L na mania, colhida 12 horas após a última dose	Diurético, anti-inflamatório e IECA aumentam a litemia; checar TSH, creatinina e cálcio; urinar muito sugere diabetes insípido	"Lítio é o pai: protege o neurônio e evita o suicídio, mas precisa ser vigiado"
Ácido valproico	Mania aguda, ciclagem rápida, estado misto, ansiedade; agressividade no antissocial	Começa com 250 mg e sobe a cada 2 dias até 750 a 1800 mg; não precisa dosar	Teratogênico: evitar em mulher fértil sem controle; rash obriga suspender	"VALPROato VALE para a mania e o misto"
Lamotrigina	Só depressão bipolar	Começa com 25 mg e sobe a cada 2 semanas até 200 a 400 mg	Rash grave se subir rápido; pode virar mania, então associar outro estabilizador	"LAMOtrigina, LÁ embaixo, sobe devagar"

Remédio	Quando usar	Como prescrever	Cuidados	Gancho
Carbamazepina	Mania, em segunda linha	Pouco usada	Muitas interações; não serve para depressão	"CARBA = carga de interações"

Na depressão bipolar: lítio, quetiapina, lamotrigina ou lurasidona. A dupla **lítio com lurasidona** serve a quem tem mais episódios depressivos. Olanzapina com fluoxetina fica só como terceira linha.

Regra de ouro: no bipolar, antidepressivo sozinho empurra o pêndulo para a mania. Se usar no episódio depressivo, retire na manutenção.

Antipsicóticos

A ideia: todos bloqueiam o receptor D2 da dopamina. Isso acalma a via da psicose, mas atinge também a do movimento (rigidez e tremor) e a da prolactina (galactorreia). Os **típicos** bloqueiam com força e dão mais rigidez; os **atípicos** bloqueiam também a serotonina 5-HT2A, o que devolve dopamina onde ela falta, com menos rigidez e mais ganho de peso.

Gancho geral: "típico endurece, atípico engorda".

Típicos

Remédio	Quando usar	Gancho
Haloperidol	Agitação aguda (injetável), psicose, paciente que não adere (depósito a cada 2 a 4 semanas); está no SUS	"HALO forte": alta potência, muito extrapiramidal
Clorpromazina e levomepromazina	Quando se quer sedar	Baixa potência: seda, baixa a pressão, efeito anticolinérgico

Atípicos

Remédio	Dose	Quando usar	Gancho
Risperidona	1 a 8 mg	Psicose; potencializa ISRS no TOC	"O mais típico dos atípicos": mais prolactina

Remédio	Dose	Quando usar	Gancho
Olanzapina	5 a 20 mg	Psicose com agitação e insônia; anorexia nervosa (ganho de peso)	"OLANZA engorda e seda"
Quetiapina	400 a 800 mg na psicose	TAB em todas as fases, gestante bipolar, delirium, demência, potencializa a depressão	"Muda com a dose": baixa dá sono, média é antidepressiva, alta é antipsicótica
Aripiprazol	Agonista parcial	Psicose, TAB, potencializa a depressão e o TOC; quem não pode engordar	"ARIPIPRAZOL não engorda, mas inquieta" (acatisia)
Brexpiprazol	Agonista parcial	Potencializa a depressão; esquizofrenia; demência	Primo do aripiprazol, mais serotoninérgico
Ziprasidona	80 a 160 mg	Quem precisa de bom perfil metabólico	Tomar com refeição de cerca de 500 kcal
Clozapina		**Esquizofrenia refratária** (falhou com 2 antipsicóticos); discinesia tardia	"CLOZApina é a última porta": hemograma semanal por 18 semanas, quinzenal por mais 18, depois mensal

Se nem a clozapina funcionar: ECT (eletroconvulsoterapia) de manutenção.

Duas emergências para lembrar:

- **Discinesia tardia:** movimento involuntário depois de anos de uso. Troca-se para clozapina para dar descanso ao D2.
- **Síndrome neuroléptica maligna:** febre, rigidez, confusão e pressão instável após dose alta. Suspender e levar para terapia intensiva.

Ansiolíticos e hipnóticos

A ideia: existem remédios que acalmam **rápido** (benzodiazepínico, pregabalina) e remédios que tratam a ansiedade **de verdade, mas devagar** (ISRS). Na prática, começa-se o ISRS e, se preciso, usa-se o rápido como ponte nas primeiras semanas.

Remédio	Como age	Quando usar	Cuidados	Gancho
Benzodiazepínicos	Reforçam o GABA, o freio do cérebro	Início do tratamento do pânico, resgate na crise, insônia por pouco tempo	Dependência, quedas no idoso, depressão respiratória; uso curto	"BZD é extintor, não é reforma"
Pregabalina	Fecha o canal de cálcio e reduz o glutamato; não age no GABA	TAG; pânico sem depressão; resposta parcial ao ISRS (sintomas físicos, bruxismo)	Tontura, sono, quedas, inchaço; ajustar na doença renal	"PREGA a porta do cálcio"
Buspirona	Agonista parcial do receptor 5-HT1A	TAG em quem tende a abusar de remédio; bruxismo causado por ISRS	Demora semanas, 2 a 3 tomadas por dia; **não funciona no pânico**	"BUSPIRONA não vicia, mas não socorre"
Zolpidem	Age na subunidade do GABA que dá sono	Só para induzir o sono	Não é ansiolítico; pode causar episódios de comer ou dirigir dormindo, sem lembrar	"ZOLPIDEM = Zzz"

Qual benzodiazepínico:

- **Clonazepam e alprazolam:** ansiedade e pânico.
- **Midazolam e flunitrazepam:** sono e sedação.
- **Diazepam:** convulsão e abstinência alcoólica, porque entra rápido no cérebro.
- **Lorazepam:** paciente com doença do fígado, porque não depende da metabolização hepática oxidativa. Gancho: **"LORAzepam LIVRA o fígado"**.

Subunidades do receptor GABA-A: a 1 dá sono, a 2 e a 3 acalmam, a 5 prejudica a memória. Gancho: **"1 dorme, 2 e 3 acalmam, 5 esquece"**.

Remédios de situações específicas

Depressão resistente ou risco de suicídio

Tratamento	Quando usar	Gancho
Antipsicótico associado (aripiprazol, brexpiprazol, quetiapina, olanzapina, risperidona)	Depressão que não respondeu ao antidepressivo	Uma das estratégias mais estudadas; o preço é o metabólico
Lítio associado	Potencializar e proteger contra suicídio	Fora do TAB, não precisa atingir litemia terapêutica
ECT (eletroconvulsoterapia)	Refratária, intolerância a remédio, risco iminente de suicídio	"ECT não tem contraindicação absoluta"
Escetamina	Resistente ou alto risco de suicídio	Bloqueia o NMDA; sempre com antidepressivo e em ambiente controlado

Trauma

- **ISRS:** primeira escolha no TEPT.
- **Doxazosina** (ou prazosina, não disponível no Brasil): pesadelos e sintomas noturnos.
- **Propranolol:** hiper-reatividade.
- **Gancho: "Alfa para o sonho, Beta para o susto".**
- **Insônia no estresse agudo:** quetiapina, trazodona ou anti-histamínico, **nunca benzodiazepínico** no primeiro mês.

TOC

Ordem da escada:

1. ISRS em **dose alta** por 12 a 20 semanas.
2. Clomipramina.
3. Antipsicótico associado: risperidona ou aripiprazol.
4. Bloqueadores do glutamato: memantina ou lamotrigina.

5. Cirurgia nos refratários.

Tricotilomania e escoriação: N-acetilcisteína acima de 2 g por dia, que modula o glutamato e reduz a impulsividade.

Transtornos alimentares

Quadro	Remédio	Gancho
Anorexia	Olanzapina (ajuda a ganhar peso e reduz obsessão); nenhum aprovado	"Na anorexia, o remédio que engorda"
Bulimia	**Fluoxetina, cerca de 60 mg** (única aprovada)	"Bulimia FLUi"; bupropiona proibida
Compulsão alimentar	**Lisdexanfetamina** (única aprovada); depois antidepressivo, topiramato, naltrexona com bupropiona	"Compulsão LISa"; não é remédio para emagrecer

- **Topiramato:** reduz compulsão e peso, mas deixa o pensamento lento.
- **Naltrexona com bupropiona:** aprovada para obesidade, funciona melhor junto com TCC.

Personalidade

- **Cluster A:** antipsicótico.
- **Antissocial com agressividade:** valproato ou antipsicótico.
- **Borderline:** remédio só para sintoma e por pouco tempo; ômega 3 tem evidência baixa; **nunca benzodiazepínico**.
- **Evitativo:** ISRS.

De trás para frente: a doença e o remédio

Use esta tabela para treinar: tape a coluna da direita e tente lembrar.

Situação	Primeira escolha	Se não resolver ou alternativa
Depressão com ansiedade e choro	ISRS	IRSN, mirtazapina, trazodona
Depressão sem energia, tabagista	Bupropiona	IRSN

Situação	Primeira escolha	Se não resolver ou alternativa
Depressão com dor crônica	Duloxetina	Tricíclico em dose baixa
Depressão na gestação	Sertralina ou fluoxetina	Escitalopram
Depressão resistente	Antipsicótico ou lítio associado	ECT, escetamina
Risco iminente de suicídio	ECT ou escetamina	Lítio a longo prazo
Mania aguda	Lítio, quetiapina ou valproato	Carbamazepina
Depressão bipolar	Lítio, quetiapina, lamotrigina, lurasidona	Olanzapina com fluoxetina
Gestante bipolar	Quetiapina	Lítio com litemia mensal
Esquizofrenia	Antipsicótico atípico	Haloperidol de depósito se não aderir
Esquizofrenia refratária	Clozapina	ECT de manutenção
Agitação psicótica aguda	Haloperidol injetável	
Delirium ou sintomas da demência	Quetiapina; brexpiprazol na demência	Sempre tratar a causa do delirium
TAG	ISRS (escitalopram, sertralina, paroxetina)	IRSN, pregabalina
Pânico	ISRS mais benzodiazepínico no início	Venlafaxina, tricíclico
Fobia específica	Exposição, sem remédio	Tratar só as comorbidades
TOC	ISRS em dose alta	Clomipramina, antipsicótico, memantina
TEPT	ISRS e terapia de exposição	Doxazosina para pesadelos
Borderline	Terapia comportamental dialética	Remédio só para sintomas
Bulimia	Fluoxetina com TCC	Sertralina, escitalopram
Compulsão alimentar	TCC; lisdexanfetamina	Topiramato, naltrexona com bupropiona
Anorexia	Reabilitação nutricional e terapia	Olanzapina

Situação	Primeira escolha	Se não resolver ou alternativa
Abstinência alcoólica	Diazepam	
Ansiedade no hepatopata	Lorazepam	
Insônia passageira	Benzodiazepínico por pouco tempo ou trazodona	Zolpidem

Proibições e armadilhas que mais caem

Cada proibição tem um motivo; se você lembrar o motivo, não esquece a regra.

Nunca faça	Por quê
Bupropiona na bulimia	Baixa o limiar convulsivo, e o vômito já altera os eletrólitos
Lamotrigina com valproato	O valproato eleva a lamotrigina e o risco de rash grave (Stevens Johnson)
Antidepressivo sozinho no bipolar	Pode virar mania, estado misto ou ciclagem rápida
Benzodiazepínico no 1º mês após trauma	Apaga a ansiedade sem processar a memória, que se grava com mais força
Benzodiazepínico no borderline	Risco de abuso e piora da impulsividade
Valproato em mulher fértil sem controle	É teratogênico
Diurético ou anti-inflamatório sem vigiar quem usa lítio	Aumentam a litemia e podem intoxicar
Lisdexanfetamina só para emagrecer	O alvo é a compulsão, não o peso
Subir a lamotrigina rápido	Risco de rash grave
Concluir que o ISRS falhou no TOC em poucas semanas	A resposta no TOC leva 12 a 20 semanas e exige dose alta
Reduzir a dose na manutenção da ansiedade	A dose usada na manutenção define o risco de recaída

Doses-limite no idoso acima de 85 anos: citalopram até 30 mg e escitalopram até 15 mg, por causa do QTc.

Retirada ou recaída? Sintomas nos primeiros dias após parar são retirada do remédio (mais comum com venlafaxina e duloxetina); sintomas que voltam após semanas são a doença retornando.

Os únicos aprovados, para fechar: fluoxetina na bulimia, lisdexanfetamina na compulsão alimentar, lamotrigina só na depressão bipolar, lítio e quetiapina em todas as fases do TAB e clozapina na esquizofrenia refratária.

Fonte: Masterclass de Psiquiatria, baseada nas apostilas das Aulas 1 a 13 (Mariana Freitas, turma 79A).